

PARECER CLÍNICO DE TELECONSULTORIA

Paciente:	Carlos Roberto da Silva	Idade:	61 anos (15/03/1965)
Protocolo:	BC261F32	Data:	22/05/2026 18:43
Especialidade:	Cardiologia	Solicitante:	Solicitante teste

1. INDICAÇÃO E HISTÓRICO CLÍNICO

Hipótese Diagnóstica Inicial: Paciente hipertenso de longa data, em uso regular de Losartana 50mg/dia. Assintomático do ponto de vista cardiovascular, mas necessita de avaliação pré-operatória para cirurgia de herniorrafia inguinal. Encaminho o ECG de repouso em anexo para estratificação de risco cirúrgico.

Hipertensão Arterial Sistêmica controlada. Risco cirúrgico habitual.

2. TRIAGEM DOCUMENTAL (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)

Paciente Carlos Roberto da Silva, 61 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica controlada em uso de Losartana 50mg/dia, assintomático do ponto de vista cardiovascular, encaminhado para avaliação pré-operatória de cirurgia de herniorrafia inguinal. O eletrocardiograma de repouso realizado para estratificação de risco cirúrgico mostrou ritmo sinusal regular com frequência cardíaca de 72 bpm, eixo elétrico normal (+60 graus), intervalo PR de 0,16s, duração do complexo QRS de 0,08s e ausência de sinais de isquemia miocárdica aguda ou áreas de inatividade elétrica. Conclui-se que o exame está dentro dos limites da normalidade, indicando baixo risco cardiovascular para a cirurgia proposta.

Grau de confiabilidade do documento de apoio (Score IA): 98%

3. CONCLUSÃO E PARECER ESPECIALIZADO

Prezado colega, o eletrocardiograma (ECG) enviado encontra-se em ritmo sinusal, sem sinais de isquemia aguda, sobrecargas cavitárias ou arritmias. O paciente apresenta risco cardiovascular baixo para a cirurgia proposta de acordo com os critérios do ACP. Sugiro manter a medicação anti-hipertensiva habitual, inclusive na manhã do procedimento. Paciente liberado para a intervenção cirúrgica sob o ponto de vista cardiológico.

Dr Cardiologista
CRM/Especialista Responsável

Assinado em: 22/05/2026 às 18:44